

Fase 1 — Propósito, Missão, Visão e Valores (confirmada)

Rationale: A Terapia do Esquema Contextual é o Como natural da marca, não um jargão genérico de nicho: é como Carolina efetivamente trabalha. O Porquê está confirmado tanto pelas frases de associação livre quanto pelo padrão consistente em 39 reels e 4 posts já publicados, e agora também pela resposta direta dela sobre missão e visão.

Why (Propósito):

Carolina acredita que ninguém se constrói sozinha. Que padrões emocionais rígidos se formam na relação, e é também através da relação que podem ser reparados. Ela existe para traduzir em palavras dores que a pessoa sente mas nunca conseguiu nomear, sem reduzir essa dor a diagnóstico, a "defeito individual" ou a sintoma isolado de um contexto social e econômico.

How (Mecanismo/Abordagem):

Terapia do Esquema Contextual. Compreender como história e contexto formaram os padrões atuais, e a partir dessa compreensão, construir uma versão mais assertiva e compassiva de si, com foco em flexibilidade psicológica e escolhas alinhadas a valores, não em eliminação de sintoma.

What (Entrega concreta):

Atendimento clínico presencial (Novo Hamburgo/RS) e online, para mulheres jovens adultas e adolescentes (exceção pontual: adolescentes homens), com foco em luto, autocrítica intensa, desafios de relacionamento, desamparo e medo de rejeição/abandono.

Missão:

Contribuir para encontrar sentido, tradução e amparo, por meio da terapia e de diferentes recursos, para dores que a pessoa sente e nunca conseguiu nomear. Ajudando cada pessoa a entender os próprios padrões para poder escolher, com mais liberdade, como se relacionar consigo e com os outros.

Visão:

Ser referência para psicólogos e pacientes, levando esse trabalho também para a palestra e a sala de aula. Sustentada por uma crença central: a terapia não é um espelho frio e neutro, é um encontro. E nesse encontro há acolhimento e presença, porque é na experiência de ser vista, ouvida e compreendida que a pessoa aprende a confiar em si, no outro e no mundo.

Valores:

- **Vínculo como caminho de reparação.** Presente na série "estilos de apego" inteira e no post em que ela descreve o envolvimento da psi como distante do "cirurgião frio".
 - **Compaixão antes de correção.** Presente nos posts sobre o modo criança vulnerável e na frase "guardar não apaga o que se sente".
 - **Contexto antes de diagnóstico, sem individualizar dor social.** Presente no post sobre o ECA e a crítica ao discurso de castigo físico, e no carrossel sobre acolhimento a pessoas autistas em contexto hospitalar.
 - **Clareza no lugar de promessa fácil.** Ela mesma nomeia isso ao dizer que seu foco não é só eliminar o sintoma.
 - **Rigor sem virar frio.** Cita Bowlby, Ainsworth, Young, Klosko e Weishaar até em legenda curta, mas reconhece o desafio de traduzir conteúdo denso sem torná-lo raso.
 - **Modelar o que ensina, com a própria vulnerabilidade.** Cita a própria terapia várias vezes ("levei pra minha psi", "já foi tópico da minha terapia pessoal"). Fala de dentro da experiência, não de cima.
-

Não-negociáveis (o que a marca recusa, mesmo que fosse mais fácil ou mais lucrativo vender assim):

- Nunca promete cura rápida, eliminação de sintoma como fim em si, ou "felicidade eterna"
- Nunca trata dor social/estrutural, como exaustão ligada ao capitalismo, como falha pessoal
- Nunca usa linguagem biomédica centrada em "defeito no cérebro" como enquadramento principal
- Nunca adota tom de coach: motivacional raso, fórmula de produtividade emocional

Fase 2 — Público-alvo e Mercado

Persona primária

Mulher, adolescente a jovem adulta, do Rio Grande do Sul, presencial em Novo Hamburgo ou online.

Como ela se vê e o que carrega:

- Aprendeu cedo a se virar sozinha e desconfia da própria necessidade de pedir ajuda, chega a interpretar isso como fraqueza ou incapacidade.
- Convive com autocritica intensa e o medo persistente de não ser o bastante, muitas vezes performando competência ou disponibilidade pros outros como forma de garantir que não vai ser deixada.

- Tem um padrão relacional marcado por medo de rejeição ou abandono. Isso aparece tanto como entrega ansiosa quanto como frieza defensiva, a pessoa costuma reconhecer um dos dois extremos nela.
- É consumidora de cultura pop com camada emocional: música, série, livro. O gatilho que a leva a parar e prestar atenção é sentir que algo nomeou uma emoção que ela nunca conseguiu colocar em palavras sozinha.
- Tem instrução ou curiosidade intelectual genuína sobre psicologia, acompanha teoria citada (Bowlby, Young) sem precisar de simplificação rasa.

Dores centrais (na voz dela)

- **Tem alguma coisa de errado comigo.** A crença de que o problema é um defeito pessoal, não um padrão aprendido em contexto. É a dor que a marca inteira existe pra desmontar.
- **As pessoas me abandonam. Eu sempre vou ficar sozinha.** Medo core de rejeição e abandono, muitas vezes construído antes da pessoa ter vocabulário pra nomear que é isso.
- **Não sei falar sobre o que eu sinto.** Não é falta de emoção, é falta de tradução. É exatamente o vazio que os reels tentam preencher usando filme, música e teoria.

Objeções reais

- **Confiar em alguém que eu nem conheço.** Não é objeção de preço nem de método, é objeção de vínculo, o que faz total sentido pra uma marca construída em cima de segurança relacional. Isso é argumento a favor de manter conteúdo que mostra Carolina como pessoa (bastidores, vulnerabilidade, referência à própria terapia) antes da primeira sessão.
- **A psi só se importa por causa do dinheiro.** Desconfiança do vínculo terapêutico como transação fria. Se conecta direto com o valor "vínculo como caminho de reparação" e com a visão dela sobre terapia não ser "espelho frio e neutro".
- **Não sei falar sobre o que eu sinto.** Aparece também como objeção, não só como dor: medo de não conseguir se expressar bem o suficiente pra terapia funcionar, ou de "não ter assunto" pra sessão.

Jobs to be Done

- Funcional: entender por que repete os mesmos padrões de relacionamento e autocrítica.
- Emocional: parar de se sentir sozinha com uma dor sem nome, sem ser reduzida a diagnóstico ou caso perdido.
- Social: encontrar um espaço onde pedir ajuda não é sinal de fraqueza.

Nível de consciência

A maior parte do público parte de consciente do problema, não da solução: sente o sintoma (exaustão, autocrítica, um padrão de relacionamento que dói) mas ainda não enquadra isso como algo que terapia resolve. O papel do conteúdo, traduzir via filme, série e música, é fazer essa ponte. Isso explica por que esse formato funciona tão bem pra ela: é o próprio mecanismo de conversão de consciência, não é só engajamento por engajamento.

Persona — Manu

Nome: Manuela ("Manu")

Idade: 22 anos

Cidade: Novo Hamburgo, RS

Profissão: Universitária, cursando o penúltimo ano de um curso na área de humanas ou comunicação, faz estágio remunerado meio período

Relacionamento: Solteira há alguns meses, término recente pesou mais do que ela esperava

Recado que ela deixaria no story: "gente como é que ninguém me avisou que virar adulta era tão difícil."

1.1 Cotidiano

Acorda cedo para se exercitar e estudar, sai para o estágio, trabalha o dia inteiro, vai correndo para a faculdade à noite, onde é muito ativa nas aulas e na comunidade acadêmica, chega em casa exausta, tenta revisar alguma coisa antes de dormir e quase sempre acaba só no celular, rolando feed, mesmo sabendo que deveria dormir. Fim de semana é a única brecha de descanso, mas boa parte do final de semana ela passa fazendo trabalhos da faculdade e, algumas vezes, no sábado à noite sai com suas amigas. Mora com os pais ainda, e isso pesa, ela queria já estar mais independente financeiramente, mas o estágio não paga o suficiente.

1.2 Perspectivas

Sobre a família: "Eu amo meus pais, mas às vezes sinto que preciso dar conta de tudo sozinha, tipo, eles fizeram o que podiam mas eu aprendi cedo que reclamar ou pedir ajuda não ia mudar muita coisa."

Raiz: aprendeu a se virar sozinha desde nova, interpreta isso hoje como força, mas sente o cansaço de nunca poder soltar as rédeas. Mesmo dependendo financeiramente dos pais, sente que já é "peso" suficiente nesse sentido, e por isso evita também pedir suporte emocional, como se usar essa segunda forma de ajuda fosse pedir demais.

Sobre relacionamentos: "Eu me entrego demais ou eu simplesmente fecho, não tem meio-termo, e cansei de ficar tentando adivinhar qual dos dois eu vou ser dessa vez."

Raiz: padrão de apego ansioso ou evitativo, ela reconhece o próprio ciclo mas não sabe nomear tecnicamente.

Sobre desempenho e valor pessoal: "Se eu não tô produzindo, entregando, ajudando alguém, eu me sinto meio inútil, tipo, o que eu valho se eu não tô fazendo nada?"

Raiz: crença de que valor é condicional à performance, não à existência.

1.3 Informação e mídia

Segue no Instagram: perfis de psicologia com linguagem acessível (do tipo da própria Carolina), contas de livros e booktok, memes de humor autodepreciativo sobre ansiedade e autocrítica.

Assiste: séries com carga emocional forte (Ginny & Georgia, The Morning Show), reality/comédia leve pra desligar (não é só conteúdo denso o tempo todo).

Ouve: playlists de "sad girl", artistas que falam de vulnerabilidade e desamparo emocional (o tipo de som que ela usa quando quer "sentir a dor com trilha sonora").

Lê: booktok, autoajuda com abordagem menos rasa quando encontra, mais TikTok e Reels do que blog ou site.

2. Maiores dores

Problema não resolvido (funcional): não sabe identificar em tempo real qual padrão dela está sendo ativado numa briga, num afastamento, numa crise de autocrítica, só sente o estrago depois.

Pior dor tangível: repete o mesmo tipo de relacionamento (ou o mesmo tipo de crise com amizade) e não entende por que sempre chega no mesmo final.

Pior dor emocional: o medo, quase automático, de que ela é difícil de amar, e que cedo ou tarde as pessoas vão perceber isso e ir embora.

Momento de maior tensão: quando alguém importante fica em silêncio ou distante por um tempo, ela já assume o pior, "deve ter feito alguma coisa errada", "vou ser deixada de novo", mesmo sem confirmação nenhuma. Ela não entende o porquê desses comportamentos, mas já enxergou um padrão.

3. Maiores desejos

Desejo não preenchido: ser escolhida e cuidada sem precisar performar disponibilidade ou perfeição o tempo todo.

Resultado não alcançado: conseguir sentir raiva, tristeza, ciúme, sem se punir depois por "estar sendo demais".

4. Crenças e resistências

Sobre terapia: acha que devia ir, já pensa nisso há tempos, mas sente que "não é tão grave assim" pra merecer o espaço, ou que vai chegar lá e não vai saber o que falar.

Maior objeção: "vou confiar numa pessoa que eu nem conheço, com coisas que eu nunca contei pra ninguém?" — e, junto disso, o medo de que terapia vire só "mais um lugar pra performar que tá tudo bem".

Objeção secundária: desconfia que psicóloga só vai enxergar ela como "mais um caso", não como pessoa. Precisa sentir, antes de agendar, que do outro lado tem um humano também.

O que ela precisa acreditar pra marcar a primeira sessão: que aquele espaço não vai julgar, não vai reduzir ela a diagnóstico, e que a psicóloga entende de verdade o que ela sente, porque já mostrou isso publicamente antes dela nem ser paciente.

5. Concorrência (o que ela considera antes de escolher Carolina)

- Outras psicólogas com Instagram ativo e linguagem parecida, ela compara tom antes de decidir.
- Plataformas de terapia online (tipo Zenklub), pela praticidade e preço, mas sente que perde a sensação de vínculo com o profissional.
- Simplesmente não ir, adiar, porque "ainda não tá tão ruim assim", esse é o concorrente mais silencioso e mais comum.

O que pesa a favor de Carolina: o conteúdo já traduziu alguma coisa que ela sentia antes de qualquer sessão acontecer, isso cria confiança adiantada, o oposto do medo de "psicóloga que só liga pro dinheiro".

Fase 3 — Posicionamento

Rationale: Com Fase 1 (propósito, mecanismo, entrega) e Fase 2 (público, dor, objeções, preço) fechadas, os quatro componentes da fórmula já existem em estado bruto no material. O trabalho aqui é redigir isso de um jeito que sobreviva ao teste de posicionamento: se um concorrente tentasse copiar a frase trocando só o nome, ela teria que soar falsa na boca dele. Testei isso abaixo.

Declaração de posicionamento

Para jovens mulheres e adolescentes que aprenderam a se virar sozinhas e carregam um histórico de vínculos instáveis, Carolina da Cunha Borba é a psicóloga que traduz, com rigor teórico e sem reduzir a pessoa a diagnóstico, dores que nunca tiveram nome, porque usa a Terapia do Esquema Contextual junto com a própria linguagem cultural dessas mulheres, filme, série, música, para fazer essa tradução acontecer antes mesmo da primeira sessão.

Decomposição, e por que cada peça é defensável

Para [público]: jovens mulheres e adolescentes com histórico de vínculo instável, não "quem sofre de ansiedade" ou "quem quer se conhecer melhor". Recorte específico o suficiente pra excluir gente, o que é o próprio teste de um posicionamento real.

Categoria: psicóloga clínica, não "coach", "mentora" ou "criadora de conteúdo sobre saúde mental". Isso parece óbvio mas precisa estar escrito, porque impede deriva de tom pro lado raso, exatamente o Não-negociável já fechado na Fase 1.

Benefício: tradução de dor sem nome em algo que pode ser pensado e sentido, sem reduzir a diagnóstico. Esse benefício é emocional antes de ser clínico, é o que a persona da Fase 2 realmente busca (ser entendida, não catalogada).

Diferencial, o ponto que precisa aguentar o teste de "outro psicólogo diria isso também?":

- *"Trabalho com Terapia do Esquema"* — não aguenta o teste, qualquer colega formado na abordagem pode dizer isso.
- *"Me importo com meus pacientes"* — não aguenta o teste, é ponto de paridade da categoria inteira, todo psicólogo deveria dizer isso.
- *"Traduzo teoria complexa usando referência cultural que minha paciente já consome, sem simplificar"* — esse aguenta. É comportamento documentado em quase dois anos de conteúdo publicado, não é slogan, é padrão real e replicado (série "estilos de apego", análises de *Divertidamente 2*, *Ginny & Georgia*, *The Morning Show*, *Hannah Montana*). Nenhum concorrente comum vai ter esse histórico pra sustentar a afirmação.

Fase 4 — Personalidade de Marca

Rationale: Personalidade de marca não é decoração, é o filtro que decide como a marca se comporta em situação ambígua, o que ela faz quando não há regra explícita cobrindo aquele momento. Com quase dois anos de conteúdo publicado, boa parte disso já está evidenciada, não é hipótese.

Arquétipo

Primário: Sábio (The Sage). Busca entender o mundo através de conhecimento e verdade, mas recusa entregar isso de cima pra baixo, ela cita teoria, referencia autores, não simplifica pra baixo, mas também nunca fala como autoridade inacessível.

Secundário: Cuidadora (The Caregiver). O que evita o Sábio de virar frio ou distante, ver Fase 1, a recusa explícita ao "cirurgião frio" como modelo de terapeuta. A combinação Sábio+Cuidadora é a mesma tensão que aparece direto no conteúdo dela: rigor teórico (cita Bowlby, Ainsworth, Young) sem nunca soltar o acolhimento (é ela mesma que se expõe, cita a própria terapia, mostra vulnerabilidade).

Não uso um terceiro arquétipo por justificativa, dois já cobrem a tensão e mais que isso dilui a marca em vez de defini-la.

Traços de personalidade (3 a 5)

1. **Curiosa e rigorosa** — trata teoria como algo que vale a pena entender direito, não simplificar até perder o sentido. Evidência: legendas curtas que ainda citam referência bibliográfica completa.
2. **Presente, não performática** — mostra bastidor, dúvida, cansaço, sem transformar isso em conteúdo de vulnerabilidade calculada. Evidência: GRWM do primeiro dia de estágio, menções à própria terapia.
3. **Tradutora cultural** — pensa em música, filme e série como ferramenta legítima de entendimento emocional, não como "gancho" raso pra prender atenção. Evidência: quase metade do conteúdo usa esse mecanismo, de forma consistente, não oportunista.

4. **Gentil, mas não evasiva** — fala de temas difíceis (violência infantil, abandono, raiva reprimida) sem suavizar a ponto de esvaziar o assunto. Evidência: post sobre castigo físico e ECA, que discorda de discurso público de forma direta.
5. **Consistente entre o que ensina e o que vive** — pratica o que promove (fala da própria terapia, do próprio processo), sem se colocar como "curada" ou "exemplo perfeito". Evidência recorrente em quase todos os reels de fala própria.

O que a marca explicitamente NÃO é

- Não é coach nem tem tom motivacional de superação rápida
- Não é fria, clínica ou distante, evita jargão que soe só pra especialista
- Não é performaticamente vulnerável
- Não é rasa, mesmo em formato curto de Reels, nunca abre mão do rigor teórico
- Não individualiza dor social/estrutural como se fosse só questão pessoal

Fase 5 — Tom de Voz

Rationale: Diferente das fases anteriores, aqui não preciso construir hipótese, o padrão de escrita dela já está documentado em 43 publicações reais. O trabalho é extrair o padrão, nomear com precisão, e transformar em regra aplicável por qualquer pessoa que for escrever por ela.

Atributos de voz

1. Rigorosa, mas nunca inacessível.

Cita referência bibliográfica (Bowlby, Ainsworth, Young, Mendes) sem nunca soar como aula.

✓ *"o experimento de Harlow mostrou que o cuidado que acolhe é tão vital quanto o que alimenta."*

✗ *"De acordo com a literatura científica sobre teoria do apego, o comportamental de cuidado materno demonstrou-se..."*

2. Pessoal, não performática.

Se expõe (própria terapia, próprias dúvidas, primeiro dia de estágio) sem transformar isso em espetáculo de vulnerabilidade.

✓ *"levei pra minha psi que eu tava tão cansada que tinha dias que só queria deitar."*

✗ *"Vou ser bem vulnerável com vocês hoje e contar um segredo que nunca revelei..."*

3. Convidativa, não professoral.

Fecha quase todo conteúdo com pergunta real, não retórica decorativa, ela genuinamente quer a resposta.

✓ *"faz sentido pra ti?" / "você já se viu nessa bagunça?"*

✗ *"Refleta sobre isso." / "Pense a respeito."*

4. Calorosa sem ser piegas.

Emoji usado com function, não decoração em excesso, paleta específica (💛💛🥹💌💙), nunca emoji genérico (🚀🌟💯).

✓ "tu merece ser cuidada 🧡"

✗ "Você é incrível e merece o mundo! 🌟💪✨"

5. Direta em tema difícil, nunca evasiva.

Fala de castigo físico, abandono, raiva reprimida, sem suavizar até esvaziar.

✓ "o problema nunca foi ela, a incapacidade era do pai de amar."

✗ "Às vezes as coisas são complicadas e cada família é de um jeito."

Espectro de tom

Eixo	Posição da marca	Nota
Formal ↔ Conversacional	Conversacional, mas gramaticalmente cuidada	Usa "tu" (marcador regional), contrações ("tá", "pra", "né"), mas nunca erra citação ou teoria
Professoral ↔ Companheira	Companheira, puxando pra Sábia quando o tema pede	Explica sem simplificar, mas nunca fala de cima
Brincalhona ↔ Séria	Predominantemente séria e calorosa, humor leve pontual	Humor aparece só em formato quiz/bastidor, nunca em tema de dor
Distante ↔ Vulnerável	Vulnerável, mas controlada	Compartilha própria experiência como ponte, não como desabafo sem função

Variações por canal

Instagram (Reels e legenda), padrão-base: o descrito acima na íntegra. Formato recorrente confirmado no material: legenda densa e educativa + CTA de engajamento no fim.

TikTok: mesma voz, mas mais permissiva com trend e formato leve (dueto, resposta a áudio, humor de bastidor). Ainda assim, tema de dor emocional segue as mesmas regras de seriedade do Instagram, a plataforma muda o formato, não o cuidado com o conteúdo.

Site: mesma voz, texto mais completo e menos fragmentado que caption de Reels (frases inteiras, menos reticência estilística), mas mantém "tu" e o mesmo grau de calor. Nunca deve soar como landing page de curso ou consultoria genérica.

Resposta a comentário sensível (alguém relata sofrimento real no comentário): aqui o tom flexiona pra mais individual e menos didático, sem citação teórica, sem tom de post educativo. Acolhe a pessoa como indivíduo, e direciona gentilmente para atendimento particular (DM ou agendamento), nunca oferece orientação clínica pública, isso não é só escolha de tom, é limite ético profissional que formalizamos na Fase 8.

Quando o tom pode flexionar, e quando nunca pode

Pode flexionar: formato (trend, humor leve, bastidor) e grau de formalidade da frase, dependendo do canal.

Nunca pode flexionar:

- Nunca vira coach, mesmo em conteúdo de trend ou humor
- Nunca banaliza tema de abuso, abandono, violência, mesmo em formato curto
- Nunca oferece orientação clínica em comentário público
- Nunca some com o rigor teórico em nome de engajamento fácil

Fase 6 — Sistema de Mensagens e Pilares de Conteúdo

Rationale: O "traduzir" já é o verbo de marca desde a Missão. Aqui ele deixa de ser conceito e vira estrutura operacional: o que postar, por quê, e que prova sustenta cada promessa. Os pilares abaixo não são invenção, são os padrões que já existem, comprovados, nas 43 publicações, organizados e nomeados pra virar sistema replicável em vez de intuição.

Elevator pitch

Carolina é psicóloga com abordagem em Terapia do Esquema Contextual, atendendo em Novo Hamburgo e online. Ela ajuda mulheres jovens e adolescentes a entender padrões emocionais que aprenderam cedo e que hoje custam caro, medo de abandono, autocrítica, dificuldade de pedir ajuda. Ela traduz teoria densa usando o que essas mulheres já sentem em filme, série e música, pra que a compreensão comece antes mesmo da primeira sessão.

BIOGRAFIA DO INSTAGRAM

- • CRP 07/46868 •
- 🧡 um lugar seguro pra quem aprendeu a dar conta de tudo sozinha
- 🗣️ falando sobre relações e dores sem nome
- terapia online ↓

Pilares de conteúdo

Cada pilar abaixo já está evidenciado no histórico, não é proposta nova, é nomeação e sistematização do que já funciona.

1. Tradução cultural

O mecanismo central da marca: pegar filme, série, música ou trend e usar como ponte pra um conceito de Terapia do Esquema.

Prova: análise de Divertidamente 2 (hipercompensação), Ginny & Georgia (people pleasing como modo protetor), The Morning Show (crença de não ser boa o suficiente), Hannah Montana (reconciliação com versão mais jovem de si), múltiplos reels com trecho de música ligado a tema emocional específico.

Critério de escolha de referência: a referência cultural precisa ilustrar um mecanismo psicológico real e nomeável, não é só "gancho" de audiência. Se a analogia não sustenta explicação clínica genuína, não vira conteúdo.

2. Educação estruturada em teoria do apego e do esquema

Conteúdo mais denso, citação de autor, explicação de conceito com rigor.

Prova: série "estilos de apego" (5 partes, experimento de Harlow → seguro → evitativo → ansioso → desorganizado), reels sobre modos esquemáticos, privação emocional, esquema de abandono.

Função estratégica: é o pilar de maior potencial evergreen, dá pra virar carrossel, e-book ou aula sem perder atualidade, distinto do pilar 1, que é mais perecível (trend passa).

3. Nomeação de padrão emocional cotidiano

Post mais curto, formato "você já se pegou fazendo isso?", nomeia um comportamento específico e liga a um mecanismo defensivo.

Prova: posts sobre choro por coisa "boba" (criança vulnerável), autossacrifício, piloto automático, autocritica como "não é você, sou eu".

Função estratégica: é o pilar de entrada mais acessível, menor barreira de atenção, geralmente maior engajamento de comentário.

4. Recusa de individualizar dor social

Conteúdo que nomeia estrutura ou contexto social por trás de um sofrimento que normalmente é tratado como falha pessoal.

Prova: post sobre ECA e crítica a discurso de castigo físico, carrossel sobre acolhimento a pessoas autistas em contexto hospitalar.

Função estratégica: pilar menos frequente no histórico (2 exemplos claros em 43 posts), mas estruturalmente importante, é onde o Não-negociável "nunca individualizar dor social/estrutural" vira prova pública, não só regra interna. Vale intencionalmente aumentar frequência.

5. Presença pessoal e bastidor profissional

Conteúdo que mostra Carolina como pessoa em formação, não só como fonte de conteúdo educativo.

Prova: GRWM primeiro dia de estágio, sala de atendimento, palestra no hospital, menções à própria terapia pessoal.

Função estratégica: resposta direta à objeção "confiar em alguém que eu nem conheço", da Fase 2, esse pilar constrói familiaridade antes da primeira sessão.

Mapa objeção → pilar que responde

Objeção (Fase 2)	Pilar que trabalha essa objeção
Confiar em alguém que eu nem conheço	Pilar 5, presença pessoal
A psi só se importa por causa do dinheiro	Pilar 5 + Pilar 2, rigor + humanidade combinados desmontam a ideia de atendimento transacional
Não sei falar sobre o que eu sinto	Pilar 1 + Pilar 3, tradução cultural e nomeação de padrão dão vocabulário antes da sessão começar

Fase 7 — História / Storytelling

Rationale: Uso o framework StoryBrand por padrão, a paciente é a heroína, Carolina é a guia, não o contrário. Isso é coerente com tudo que já foi fechado: a Fase 3 recusa "cirurgião frio" e a Fase 4 define Carolina como Sábia+Cuidadora, papéis de guia, não de protagonista. A história da própria Carolina entra só como prova de credibilidade da guia, não como arco central, porque é isso que o material sustenta, ela se expõe pra criar confiança, não pra centralizar atenção nela mesma.

Arco StoryBrand aplicado à paciente (heroína)

Personagem: jovem mulher ou adolescente que aprendeu a se virar sozinha, carrega histórico de vínculo instável, sente que tem algo de errado com ela.

Problema externo: repete os mesmos padrões de relacionamento, entrega demais ou se fecha, e não entende por quê.

Problema interno: acredita, no fundo, que é difícil de amar e que vai ficar sozinha, mesmo sem evidência disso, ver o Esquema de Abandono/Instabilidade da Fase 2.

Problema filosófico: ninguém deveria ter que carregar sozinha uma dor que nunca teve chance de ser nomeada, ou ser reduzida a diagnóstico quando essa dor tem raiz em contexto e vínculo, não em defeito pessoal.

Guia: Carolina, com empatia (ela mesma já esteve em terapia, entende o processo de dentro, não fala de cima) e autoridade (Terapia do Esquema Contextual, formação, teoria citada com rigor).

Plano: entender o padrão em contexto, não como falha, construir vocabulário pra nomear o que nunca teve nome, e a partir disso, escolher com mais liberdade como se relacionar consigo e com os outros. Corresponde direto à Missão já fechada.

Chamado à ação: agendar uma sessão, presencial em Novo Hamburgo ou online, depois de já ter sentido, pelo conteúdo, que aquele espaço traduz e não julga.

Sucesso: relação mais segura consigo mesma e com os outros, conseguir pedir ajuda sem achar isso fraqueza, sentir raiva ou tristeza sem se punir por "estar sendo demais".

Fracasso evitado: continuar repetindo o ciclo sozinha, achando que o problema é ela, sem nunca ter linguagem pra entender o que está de fato acontecendo.

Credibilidade da guia (o quanto e como a própria história de Carolina aparece)

O material já mostra o padrão certo aqui: ela se expõe o suficiente pra provar que fala de dentro da experiência, não de fora, sem transformar isso em arco de ego. Aparece como menção pontual ("levei pra minha psi", referências à própria terapia pessoal, bastidor de primeiro dia de estágio), nunca como narrativa longa sobre "minha jornada". Isso deve continuar sendo o padrão: a história dela é pano de fundo de credibilidade, a da paciente é o centro.

Origem, na voz dela (já publicada, reaproveitável)

"Ser humano é, acima de tudo, sentir. Viver é, inevitavelmente, sentir vulnerabilidades, afetos e emoções que muitas vezes escondemos, pois fomos culturalmente ensinados a fazê-lo. Acredito que todos nós carregamos uma criança interior que precisa ser acolhida, ouvida e protegida, e vejo nas relações um poder genuinamente reparador nesse sentido. Quando muito precisei, uma psicóloga me lembrou que eu não estava sozinha, e é isso que desejo proporcionar a outras pessoas: oferecer a mesma segurança e amparo."

Por que essa passagem funciona tão bem pro manual:

- Confirma o mecanismo Sábia+Cuidadora da Fase 4: fala de "campo de estudo" e "transformações coletivas" (Sábia) na mesma respiração que fala de acolhimento e criança interior (Cuidadora).
- A frase "quando muito precisei, uma psicóloga me lembrou que eu não estava sozinha" é o momento de virada real da história dela, ela foi heroína antes de ser guia, viveu o mesmo tipo de solidão que a persona de hoje vive, e foi atravessada por alguém que fez o que ela agora quer fazer. Isso é StoryBrand funcionando organicamente, sem precisar forçar estrutura.
- Reforça direto o Não-negociável "nunca cirurgião frio", ela não escolheu a profissão por fascínio técnico distante, escolheu porque foi amparada.

Abordagem clínica, no porquê dela

Escolheu Terapia do Esquema Contextual pelo olhar integrativo.

Curto, mas correto, e casa com o valor já fechado na Fase 1, "Rigor sem virar frio". A abordagem integra teoria do apego, psicanálise, gestalt e terceira onda, em vez de se fechar numa lente só. Vale manter essa frase como resposta padrão sempre que alguém perguntar "por que essa abordagem", sem precisar elaborar mais que isso.

Fase 8 — Diretrizes de Redação

Rationale: Essa fase tem duas camadas que não podem se misturar: **regra de marca** (o que já vem sendo construído desde a Fase 1, tom, valores, recusas) e **regra ética/legal** (o que o Conselho Federal de Psicologia exige, independente de qualquer preferência de marca). A segunda camada não é negociável nem por mim nem por vocês, porque envolve risco profissional real para o CRP dela. Busquei a normativa atual antes de escrever isso, não vou inventar regra de conselho profissional.

Regras de conformidade CFP (camada legal, não estilística)

Identificação obrigatória. Toda publicidade profissional, incluindo redes sociais, precisa apresentar título de Psicóloga, nome completo (sem abreviação de sobrenome) e número de registro no CRP. Ao promover seus serviços em quaisquer meios, a psicóloga deve apresentar obrigatoriamente o título de psicóloga, seu nome completo e o número do registro profissional.

Proibido prometer resultado. A publicidade profissional não deve ter cunho sensacionalista, nem previsão taxativa de resultados ou autopromoção em detrimento de outros profissionais, práticas vedadas pelo Código de Ética. Isso reforça, com força legal, o Não-negociável de marca já fechado na Fase 1 contra cura rápida.

Publicidade enganosa ou abusiva é vedada. É vedada a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas ou cláusulas abusivas impostas no fornecimento de serviços.

Sigilo em qualquer conteúdo público. Qualquer temática apresentada em palestras, entrevistas ou outras formas de comunicação com a sociedade deve ser realizada garantindo a preservação da identidade e intimidade das pessoas envolvidas, respeitando o sigilo profissional. Isso vale mesmo pra "casos" fictícios ou compostos, se soar identificável, tratar com cuidado extra.

Título só se realmente possuído. A profissional só pode divulgar referência a título de especialista, mestre ou doutora se de fato possuir diploma que valide o título. Ela pode dizer "abordagem em Terapia do Esquema Contextual", não pode dizer "especialista" nesse tema até ter título formal de especialização reconhecido.

Glossário de termos, marca + CFP combinados

Termo/Frase	Status	Por quê
"Cura rápida", "resultado garantido", "em poucas sessões você vai..."	Banido	Viola Não-negociável de marca E é vedado pelo CEPP como previsão taxativa de resultado

"Você tem depressão/ansiedade/transtorno de..." em conteúdo público	Banido	Diagnóstico não se faz em post, é risco ético e clínico grave
Linguagem de "defeito no cérebro" ou puramente biomédica como enquadramento principal	Banido	Contradiz Não-negociável de marca sobre individualização e reducionismo
Tom de coach ("desperte seu potencial", "mude sua vida em X dias")	Banido	Contradiz Personalidade de marca (Fase 4) e recusa explícita de tom motivacional raso
Relato de caso clínico real, mesmo anonimizado, sem cuidado extra de descaracterização	Banido	Risco de sigilo profissional
"Psicóloga especialista em..." antes de título formal de especialização	Banido até ter o título	Vedado pelo CEPP
"Trauma", "traumatizada" usado como rótulo clínico solto, sem contexto explicativo	Banido nesse uso	Funciona como diagnóstico informal disfarçado de linguagem cotidiana — mesmo risco do item de diagnóstico acima, só que com termo mais naturalizado nas redes. Se o conceito for necessário, precisa vir explicado (mecanismo, não etiqueta)
"Vítima" (para descrever paciente ou situação relatada)	Banido	Reforça o enquadramento que a marca já recusa no Não-negociável de individualizar/rotular dor — coloca a pessoa em posição passiva e fechada, o oposto do "entender padrão em contexto" que é a proposta da marca

Qualquer comparação, implícita ou explícita, com outros profissionais ("diferente da maioria dos psicólogos que...", "ao contrário de outras abordagens que só...")	Banido	Vedado pelo CEPP como autopromoção em detrimento de colegas — é regra que já estava citada em prosa na Fase 8 original, agora formalizada como linha de glossário para evitar que passe despercebida em revisão rápida
"Traduzir", "tradução", "nomear o que não tem nome"	Aprovado, termo-âncora	Verbo de marca já confirmado, único, defensável
"Padrão", "esquema", "modo" (linguagem técnica da Terapia do Esquema)	Aprovado, com explicação sempre junto	Mantém rigor sem virar jargão fechado
"Contexto", "em vez de defeito"	Aprovado, recorrente	Sustenta Não-negociável anti-individualização
"Abordagem em Terapia do Esquema Contextual"	Aprovado	Frase correta, sem alegar especialização formal ainda não obtida
Representações simbólicas/compostas de caso, com aviso explícito de que não é caso real	Aprovado, com nota obrigatória	Ela já faz isso corretamente em um dos posts ("esse conteúdo é uma representação simbólica, não trata de uma história específica"), esse padrão deve virar regra fixa sempre que o conteúdo se aproximar de relato de caso

Regras de escrita e formatação (estilo)

- Uso de "tu" mantido, é voz autêntica, não regionalismo forçado
- Contrações informais ("tá", "pra", "né") permitidas em Instagram/TikTok, reduzidas (não eliminadas) no site
- Emoji com função semântica, nunca decorativo em excesso, paleta já mapeada na Fase 5 (💛💛💛🥺📧👤)
- CTA final de post deve ser pergunta real, não retórica vazia, conforme padrão já identificado

- Toda citação de autor/teoria (Bowlby, Young, Ainsworth etc.) deve ser factual, sem simplificação que distorça o conceito original

Fase 9 — Aplicações

Rationale: Aqui a marca sai da definição e vira uso real, onde cada regra das Fases 1 a 8 precisa aparecer em texto pronto pra publicar, não em princípio abstrato. Vou construir Bio e Sobre Mim com o material real que já temos (a passagem publicada dela sobre "por que escolhi psicologia", o verbo "traduzir", o posicionamento fechado), e mapear onde cada canal aplica as regras de tom e conteúdo já fechadas.

Bio Instagram

• CRP 07/46868 •

💛 um lugar seguro pra quem aprendeu a dar conta de tudo sozinha

🧡 falando sobre relações e dores sem nome

terapia online ↓

Texto "Sobre Mim" (site)

Baseado quase integralmente na passagem que ela já escreveu e publicou, com ajuste de estrutura pra formato de site, sem reescrever a voz dela:

Sou Carolina Borba, psicóloga com abordagem em Terapia do Esquema Contextual, atendendo em Novo Hamburgo e online.

Acredito que ser humano é, acima de tudo, sentir. Viver é, inevitavelmente, sentir vulnerabilidades, afetos e emoções que muitas vezes escondemos, porque fomos culturalmente ensinados a fazê-lo. Acredito que todos nós carregamos uma criança interior que precisa ser acolhida, ouvida e protegida, e vejo nas relações um poder genuinamente reparador nesse sentido.

Quando muito precisei, uma psicóloga me lembrou que eu não estava sozinha. É isso que desejo proporcionar às pessoas que atendo: a mesma segurança e amparo.

Escolhi a Terapia do Esquema Contextual pelo olhar integrativo, ela une teoria do apego, elementos da psicanálise, da gestalt e das terapias contextuais pra entender como padrões emocionais se formam na infância e continuam moldando a forma como nos relacionamos hoje, com nós mesmas e com os outros.

No consultório, meu trabalho não é eliminar sintoma como fim em si. É ajudar você a entender os próprios padrões, no seu contexto, sem reduzir sua dor a

diagnóstico, pra que possa escolher, com mais liberdade, como quer se relacionar consigo e com o mundo.

Mapa de aplicação por canal

Instagram: aplica integralmente Fases 5 (tom), 6 (pilares) e 8 (glossário). Formato-base confirmado: legenda densa e educativa + CTA de pergunta real.

TikTok: mesma voz, formato mais permissivo com trend/humor leve, nunca em tema de dor (regra da Fase 5 mantida).

Site: aplica Sobre Mim acima, elevator pitch da Fase 6 na página inicial ou "Sobre o atendimento", e declaração de posicionamento da Fase 3 pode orientar a estrutura da home (público, benefício, diferencial, em ordem).

Resposta a comentário sensível: segue regra já fechada na Fase 5, tom individual, sem citação teórica, direciona gentilmente pra DM/agendamento, nunca orientação clínica pública.